

ΟΞΕΙΑ ΠΑΡΑΡΡΙΝΟΚΟΛΠΙΤΙΔΑ

Γενικά: Στην οξεία βακτηριακή παραρρινικολπίτιδα, μικρόβια που ενοχοποιούνται κυρίως είναι: ο *Streptococcus pneumoniae*, ο *Haemophilus influenzae* και η *Moraxella catarrhalis*. Στην υποξεία και τη χρόνια παραρρινικολπίτιδα ενοχοποιούνται τα προειρημένα στελέχη, με συμμετοχή όμως και αναερόβιων (*Prevotella*, *Actinomyces*, *Fusobacterium*, κ.ά.).

Κλινική εικόνα: Ο ασθενής παραπονιέται για απόφραξη της ρινός, πυώδη ρινική έκκριση, κακουχία, κεφαλαλγία, οδονταλγία, αίσθημα βάρους στο πρόσωπο που επιδεινώνεται όταν σκύβει, δακρύρροια και συχνά πυρετό. Τα συμπτώματα συνήθως είναι εντονότερα το πρωί.

Ιστορικό: Ερευνούμε το χρόνο και τρόπο έναρξης και τη διάρκεια των συμπτωμάτων. Ελέγχουμε για συννοσηρότητες (άσθμα, τραύμα κρανίου, ΣΔ) ή για φάρμακα που λαμβάνει ο ασθενής. Συνήθως το επεισόδιο που αντιμετωπίζουμε δεν είναι το πρώτο για τον ασθενή. Η διάρκεια των συμπτωμάτων μπορεί να κυμαίνεται από 7 ημέρες έως και 3-4 εβδομάδες.

Θεραπευτική παρέμβαση

Η χορήγηση αντιβιοτικών περιορίζεται για τους ασθενείς με μέσης βαρύτητας ή σοβαρά εμμένοντα συμπτώματα, τα οποία διαρκούν περισσότερο από 10 ημέρες ή επί υπάρξεως βλεννοπυωδών εκκρίσεων διάρκειας άνω των 10 ημερών ή επί οδονταλγίας της άνω γνάθου και μη ύφεσης ή επιδείνωσης των συμπτωμάτων μετά την αρχική συντηρητική θεραπεία.

1. **Στην οξεία μορφή** και επί ενδείξεων, με βάση τα ανωτέρω, μπορούμε να χορηγήσουμε:

- **Amoxi-Clav** (*Augmentin/Fugentin*), 625 mg 1x3 ή 1 g 1x2 (po), για 7 ημέρες ή
- **Cefprozil** (*Procef/Pricefil*), 500 mg 1x2 (po), για 7 ημέρες ή
- **Cefuroxime** (*Zinadol/Medoxem*), 500 mg 1x2 (po), για 7 ημέρες ή
- **Cefditoren** (*Spectracef*), 400 mg 1x2 (po), για 7 ημέρες.

Εναλλακτικά, στην οξεία μορφή (ιδίως επί αλλεργίας στα β-λακταμικά), χορηγούμε:

- **Clarithromycin** (*Klaricid/Viaclar*), 500 mg, 1x2 (po), για 7 ημέρες ή
- **Doxycycline** (*Vibramycin/Smilitene*), 100 mg, 1x2 (po), για 7 ημέρες ή τέλος
- **Azithromycin** (*Zithromax/Zithotel*), 500 mg, 1x1 (po), για 3 ημέρες.

2. **Στην υποτροπιάζουσα μορφή** (νόσος με ≥ 4 επεισόδια ανά έτος) ή σε πρόσφατη χρήση των προειρημένων κατηγοριών αντιβιοτικών (κατά το τελευταίο 3μηνο), χορηγούνται:

- ▶ **Moxifloxacin** (*Avelox/Octegra*), 400 mg, σε δόση 1x1 (po), για 7 ημέρες ή
- ▶ **Levofloxacin** (*Tavanic/Evoxil*), 500 mg, σε δόση 1x1 (po), για 7 ημέρες ή
- ▶ **Ceftriaxone** (*Rocephin/Veracol*), 1 g, σε δόση 1x1 (im), για 7 ημέρες ή
- ▶ **Metronidazole** (*Flagyl*), 500 mg, 1x3 (po), μαζί με κάποιο β-λακταμικό αντιβιοτικό (*Πενικιλίνη ή Κεφαλοσπορίνη*) για θεραπεία της οξείας/βαριάς νόσου, επί 7 ημέρες ή
- ▶ **Clindamycin** (*Dalacin*), 300 mg, 1x3 ή 1x4 (po), μαζί με β-λακταμικό αντιβιοτικό, για οξεία ή σοβαρή μορφή, επί 10 ημέρες. Επί χορηγήσεως Κλινδαμυκίνης θεωρείται σκόπιμη η προσθήκη *Saccharomyces boulardii* προς αποφυγή διαρροϊκού συνδρόμου, ήτοι: caps. *Ultralevure* 250 mg, 1x1 ή 1x2, (po), 30-60 λεπτά προ του φαγητού.

3. Αποφεύγουμε την ταυτόχρονη χορήγηση τοπικών (spray) ρινικών αποσυμφορητικών – συμπαθομιμητικών φαρμάκων, γιατί πιστεύεται ότι λόγω της τοπικής αγγειοσυσπασσης που προκαλούν, περιορίζουν τη συγκέντρωση των αντιβιοτικών στον πάσχοντα κόλπο. Παρόλα αυτά, ρινικές πλύσεις με διάλυμα Sinus Rinse, δις ημερησίως, βοηθά αισθητά!

4. Για τη θεραπεία της χρόνιας επιμένουσας παραρρινικολπίτιδας απαιτείται διαγνωστική παρακέντηση από ειδικό και λήψη καλλιιεργειών για αερόβια και αναερόβια μικρόβια.

5. **Η οξεία ηθμοειδίτιδα**, που ακολουθεί το κοινό κρυολόγημα, είναι βραχυχρόνια και δεν απαιτεί αντιβιοτικά. Γι' αυτό, εφόσον ο ασθενής δεν εμφανίζει πυρετό, ή τοπικά σημεία οιδήματος με έντονη κεφαλαλγία, συνιστάται αναμονή χωρίς αντιβιοτικά επί 6-7 ημέρες κι εφόσον η ρινο-πυόρροια συνεχίζεται, τότε μόνο χορηγείται η κατάλληλη αντιβίωση.